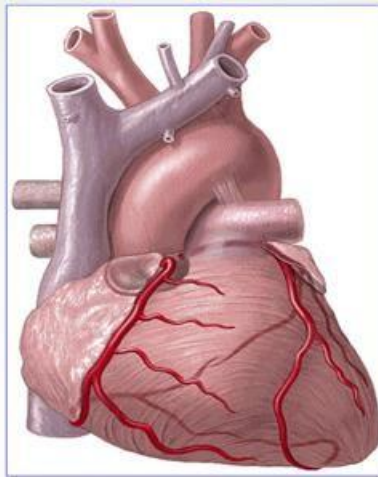




**Polycopié à l'usage des étudiants de 3^{ème} année de Médecine
Unité d'Enseignement Intégrée (UEI 1)**



« Examen cardiaque : inspection, palpation et percussion »

Pr HARZOUZ. Slimane

Maître de conférences A en Médecine interne

HMRUC

21/10/2025

Année universitaire 2025-2026

I- Introduction :

La **sémiologie cardiaque** regroupe le recueil :

- ✓ **Des signes fonctionnels :** ➡ Plaintes formulées par les patients.
- ✓ **Et des signes physiques :** ➡ Retrouvés lors de l'examen clinique.

La prise en charge médicale impose de recueillir **les antécédents médicaux personnels et familiaux** du patient.

- ✓ De rechercher les «**facteurs de Risque**» prédisposant **aux affections cardiaques** les plus fréquentes, de rechercher les signes d'éventuelles maladies.



II- Conditions pour l'examen cardiaque :

- ✓ **Les instruments** : stéthoscope, lampe, abaisse-langue, montre, gants, tensiomètre, mètre ruban.
- ✓ L'examen clinique doit être fait dans une pièce calme à une température confortable.
- ✓ L'examen clinique comporte :

- **L'interrogatoire.**
- **L'inspection.**
- **La palpation.**
- **La percussion.**
- **Et l'auscultation +++.**



- ✓ Examen se fait : « position décubitus dorsal, décubitus latéral gauche, assise penchée en avant, debout respiration normale, apnée respiratoire et en fin d'expiration ».
- ✓ Temps essentiel de l'examen clinique, indispensable à l'établissement d'un diagnostic.

L'interrogatoire permet :

- De déterminer le motif de consultation.
- De recueillir les antécédents et le mode de vie.
- D'établir l'histoire de la maladie.



Pas cool

Cool

« Antécédents personnels et familiaux »

- **Antécédents personnels** : en trois parties :

- Les antécédents cardiovasculaires.
- Les antécédents médicaux.
- Les antécédents chirurgicaux.
 - **Et de préciser** les hospitalisations antérieures.

III- Interrogatoire du patient :

III-A Les antécédents cardiovasculaires :

- ✓ Les coronaropathies et antécédents d'infarctus du myocarde.
- ✓ Les valvulopathies.
- ✓ Les épisodes d'insuffisance cardiaque.
- ✓ Les troubles de la conduction.
- ✓ Les troubles du rythme.
- ✓ Les épisodes de thrombose veineuse profonde et/ou d'embolie pulmonaire.
- ✓ La présence de pathologie vasculaire « l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI).
- ✓ Les autres cardiopathies.
- ✓ Les autres antécédents médicaux et chirurgicaux.

III-B Antécédents familiaux :

Tous les antécédents familiaux sont recherchés, particulièrement ceux de **maladies cardiovasculaires athéromateuses**.

- ✓ L'artériopathie oblitérante des membres.
- ✓ La coronaropathie.
- ✓ L'accident ischémique cérébral.
- ✓ **Précoces** (moins de **55 ans pour l'homme, 65 ans pour la femme**).
- ✓ Chez des parents du premier degré (**père, mère, frère, sœur**).

III-C Facteurs de risque cardio-vasculaires :

Ce sont des situations qui vont exposer le patient au risque de développer un événement cardio vasculaire en plus par rapport aux autres individus de la population générale.

- ✓ L'âge supérieur à 50 ans chez l'homme et 60 ans chez la femme.
- ✓ Le sexe masculin.
- ✓ L'hypertension artérielle.
- ✓ Le diabète.
- ✓ Le tabagisme avec l'âge de début, l'âge de fin, le nombre de paquets-années ainsi qu'un sevrage inférieur à trois ans.
- ✓ La dyslipidémie, le traitement pris.
- ✓ L'hérédité cardiovasculaire : infarctus du myocarde ou mort subite avant l'âge de 55 ans chez le père ou un parent du premier degré de sexe masculin ; ou infarctus du myocarde ou mort subite avant l'âge de 65 ans chez la mère ou un parent du premier degré de sexe féminin.

- ✓ L'obésité : IMC (indice de masse corporelle) > 30 kg/m² (surpoids : IMC > 25kg / m²).
- ✓ La sédentarité.

IV- Principaux signes fonctionnels cardiovasculaires :

Les **symptômes fonctionnels cardiaques** les plus fréquents sont :

- ✓ **Les douleurs thoraciques.**
- ✓ **La dyspnée.**
- ✓ **Les pertes de connaissance : les lipothymies, syncopes.**
- ✓ **La claudication intermittente des membres inférieurs.**

Il faut également rechercher la présence **d'une toux** et **d'épisodes d'hémoptysie**.

IV- A Les douleurs :

- ✓ **Les douleurs thoraciques** sont étudiées en détail dans le cours « les douleurs thoraciques ».
- ✓ Et **les douleurs vasculaires** dans le cours « sémilogie vasculaire ».

Caractéristiques des douleurs thoraciques ou vasculaires :

- ✓ Circonstances d'apparition, siège.
- ✓ Type facteurs aggravants, facteurs apaisants.
- ✓ Irradiation/migration, durée.
- ✓ Fréquence de survenue.
- ✓ Signes associés.

IV- B La dyspnée :

C'est la **perception consciente d'une gêne respiratoire**, une sensation de manque d'air avec essoufflement. Étudiée en détail dans le cours « les dyspnées ».

IV- C Les palpitations, les malaises :

C'est la **perception anormale et déplaisante des battements cardiaques** ressentis plus forts et/ou plus rapides, anormalement puissants.

Étudiés en détail dans le cours « les palpitations ».

IV- D Les pertes de connaissance : les lipothymies, syncopes » :

La **syncope** est une perte de connaissance subite de brève durée due à une baisse transitoire du débit sanguin cérébral.

La **lipothymie** est un malaise sans réelle perte de connaissance.

Étudiée en détail dans le cours « les syncopes ».

IV- E La claudication intermittente des membres inférieurs :

C'est **une douleur** due à l'insuffisance artérielle au niveau des membres inférieurs. C'est une douleur ischémique. Les artères des membres inférieurs étant sténosées, il en résulte une diminution de l'apport sanguin, à l'effort, il y a un déséquilibre entre l'apport et les besoins.

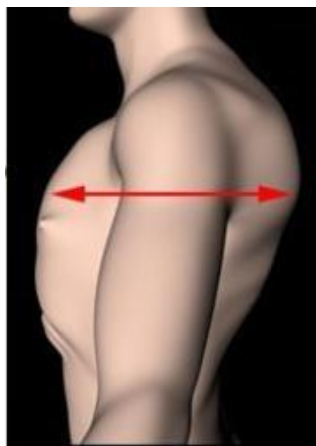
Étudiée en détail dans le cours « sémilogie vasculaire ».

V- Examen du patient : recueil des signes physiques »

V-1 Inspection :

Chez le **sujet normal**, l'examen de la Région précordiale ne montre rien. L'inspection du thorax peut occasionnellement fournir des informations utiles :

A- Morphologie : thorax « en tonneau » des insuffisants respiratoires, thorax « en entonnoir » (*pectus excavatum*), cypho-scoliose.



thorax en tonneau



thorax en entonnoir



cyphoscoliose.

- ✓ **Présence de cicatrices**, notamment de chirurgie cardiaque ou vasculaire.
- ✓ **Circulation veineuse collatérale**, œdème « en pèlerine ».



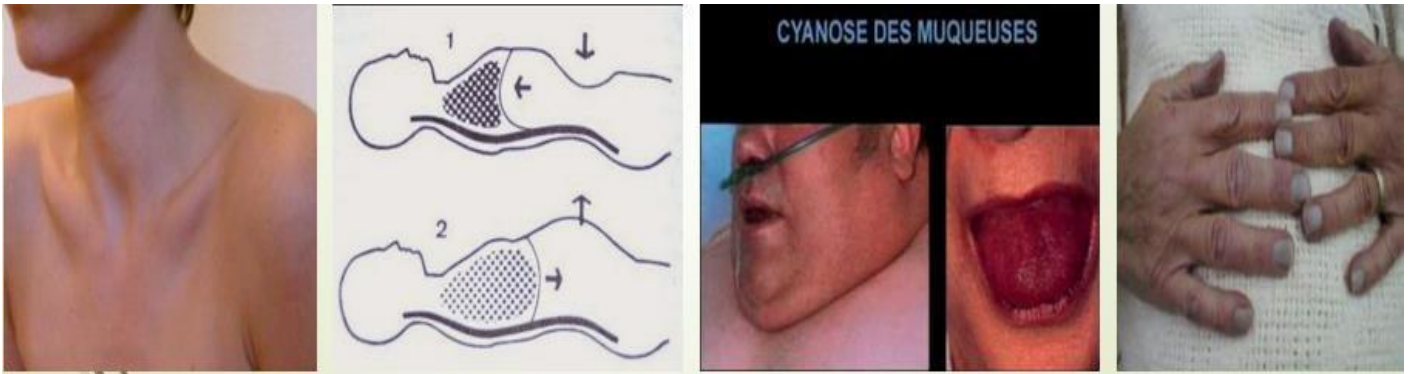
Cicatrice de chirurgie cardiaque



CVC

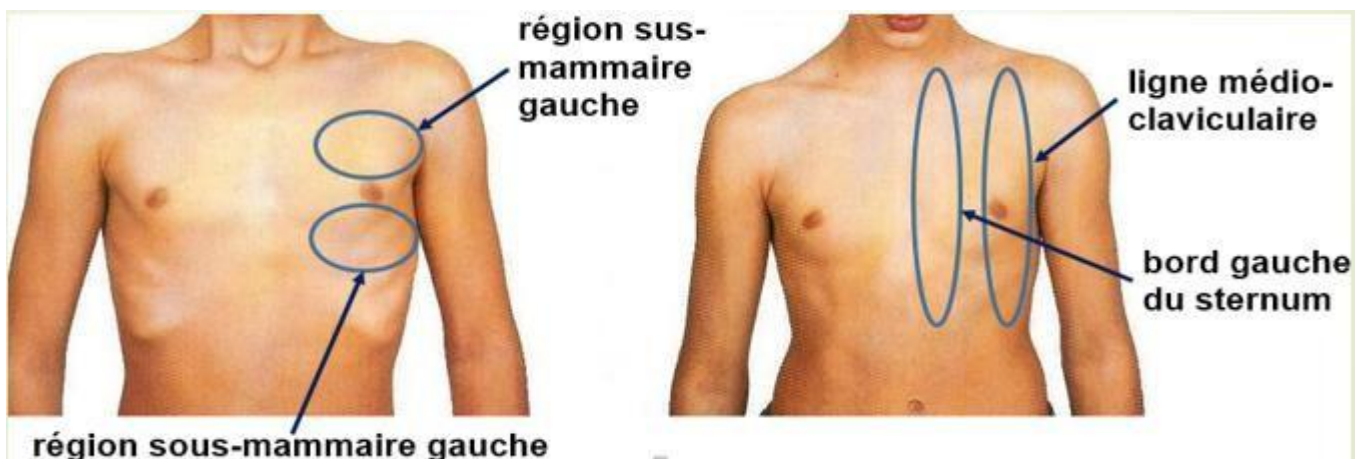
B- Fréquence respiratoire :

- ✓ Normale < **15/min** au repos chez l'adulte.
- ✓ **Qualité de la respiration (pénibilité, régularité)** : dyspnée de repos, orthopnée, **une polypnée** (fréquence respiratoire > 20/min).
- ✓ **Un tirage sus-claviculaire, une respiration abdominale, une cyanose** voire un épuisement respiratoire avec **une bradypnée**.



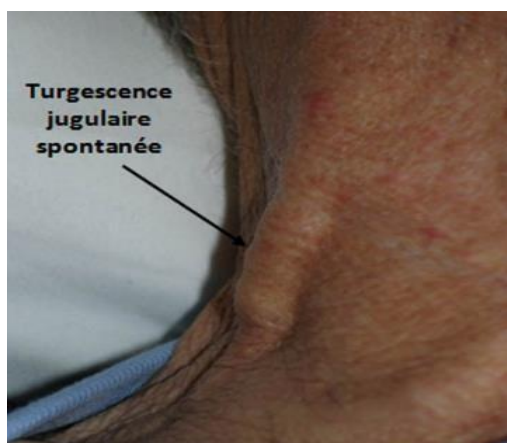
Recherche de **pulsations visibles** :

- ✓ **A gauche de la ligne médio-claviculaire**, suggèrent une dilatation du cœur gauche.
- ✓ **Le long du bord gauche du sternum**, plaident pour une dilatation du cœur droit.
- ✓ **Un soulèvement de la paroi thoracique**, synchrone du pouls, dans la **région sus-mammaire gauche**, peut témoigner d'un anévrisme pariétal du ventricule gauche.



Signes d'insuffisance cardiaque droite :

- ✓ Turgescence jugulaire.
- ✓ Les œdèmes des membres inférieurs :
 - Blancs , parfois rouge et douloureux.
 - Mous.
 - Bilatéraux.
 - Situés préférentiellement au niveau des chevilles et en effacent les reliefs naturels.



V-2 Palpation :

V-2-1 Palpation thoracique :

La palpation, réalisée avec des mains réchauffées, permet de rechercher :

- A- Le **choc de la pointe du cœur**.
- B- Les **frémissements** chez certains patients atteints de valvulopathies.
- C- Et de recueillir **des signes d'insuffisance cardiaque**.

1- Comment rechercher le choc de pointe ?

- ✓ Il est localisé au niveau du **cinquième espace intercostal gauche**.
- ✓ Au niveau de la **ligne médioclaviculaire**.
- ✓ Mieux perçu sur un sujet en **décubitus latéral gauche**.



Variations pathologiques du choc de pointe :

- ✓ **Diminution ou disparition :**
 - Obésité.
 - Emphysème.
 - Épanchement péricardique.
 - Insuffisance cardiaque.
- ✓ **Augmentation d'intensité :** fièvre, hyperthyroïdie.
- ✓ **Globuleux en dôme de bard :** insuffisance aortique.
- ✓ **En cas de cardiomégalie**, le choc de pointe est dévié en bas et en dehors (à gauche).

2- Les Frémissements sont la traduction tactile des souffles.

- ✓ Ils ont une très grande valeur lorsqu'ils sont nets et prolongés.
- ✓ L'exemple du frémissement au cours du **rétrécissement mitral (RM)**.



3- **Signe de Harzer** : perception des battements cardiaques au niveau de la région sous xiphoïdienne, témoin d'une **hypertrophie du ventricule droit**.

► Un signe inconstant observé dans l'**insuffisance cardiaque droite**.



V-2-2 Palpation abdominale :



La palpation abdominale recherche :

- ✓ **Une hépatomégalie.**
- ✓ **Et le reflux hépatojugulaire.**

Deux signes d'insuffisance cardiaque droite.

- ✓ **Le reflux hépatojugulaire** se recherche chez un patient en position demi-assise, à 45°.
- ✓ Le malade respire normalement.
- ✓ La palpation effectuée au niveau de l'hypochondre droit entraîne le remplissage des veines jugulaires pendant le temps de la compression et quelques secondes après.

V-3 Percussion :

La percussion est réalisée en tapant avec l'extrémité du majeur de la main droite sur les doigts de la main gauche (en général au niveau de la deuxième phalange du majeur) placée à plat sur le thorax du patient.

- ✓ Elle est peu utile pour l'examen du cœur.
- ✓ Très utilisée au niveau **pleuropulmonaire** pour rechercher des épanchements liquidiens ou aérique.
- ✓ **La Percussion Abdominale** permet de rechercher **une Hépatomégalie** ou **une Ascite** au cours d'une insuffisance cardiaque.



Merci